

Vakdossier MSc Manuele Therapie

CAT diagnostiek · student 1 · destijds beoordeeld door Marloes de Graaf op 09-12-2025

Naam _____ Datum _____

Ik werk bij ☐ MSc Manuele Therapie ☐ Master Kinderfysiotherapie ☐ POH-6 Huisartsenzorg ☐ anders

Wat jullie zeiden, en wat Eduface zegt

Dezelfde CAT, dezelfde rubriek, twee beoordelaars. De gemarkeerde regels lopen uiteen.

	MARLOES, 09-12-2025	EDUFACE, VANDAAG	
1. Algemeen	4 van 4 voldaan	FAIL	VERSCHIL
2. Klinisch scenario (stap 1)	2 van 3 voldaan	PASS	OMGEKEERD
3. Klinische vraagstelling (stap 2)	5 van 5 voldaan	PASS	EENS
4. Zoekstrategie (stap 3)	6 van 6 voldaan	FAIL	VERSCHIL
5. Kritische evaluatie (stap 4)	2 van 2 voldaan	PASS	EENS
6. Evidentietabel (stap 5)	2 van 2 voldaan	FAIL	VERSCHIL
7. Commentaar (stap 6)	2 van 2 voldaan	FAIL	VERSCHIL
8. Bottom line (stap 7)	1 van 1 voldaan	FAIL	VERSCHIL

MARLOES

24 van 25 voldaan

Eindoordeel: voldaan

EDUFACE

3 van 8 onderdelen PASS

Vijf onderdelen op FAIL

OVEREENSTEMMING

2 van de 8

Vijf keer strenger, één keer milder

De feedback die Marloes destijds schreef

Het volledige feedbackveld, letterlijk overgenomen.

"Hey Jurre, Deze opdracht heb je afgerond. Je hebt hier en daar wel wat kort door de bocht uitgevoerd. Maar dat is bij deze opdracht nog niet z'n probleem."

De volledige feedback van Eduface

Acht rubriekcriteria, letterlijk zoals het model ze schreef. Dit is wat je beoordeelt.

1. Algemeen FAIL

De CAT bevat taal- en terminologiefouten en maakt redenering tussen stappen 1 tot 7 onvoldoende controleerbaar; vooral stap 4 tot 6 missen onderbouwing van interne validiteit, diagnostische kernmaten en bruikbaarheid. Dit verhindert navolgbaarheid. Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst; voeg zoekdatum, databank, zoektermen, voorafkants, in- en exclusiecriteria en berekeningen toe en verbind ze met bottom line.

2. Klinisch scenario (stap 1) PASS

Bij stap 1 presenteer je patiëntkenmerken en onderzoeksbevindingen kernachtig en verbind je deze logisch aan de hypothese. Echter, formuleer de hypothesen vóór de bevindingen en onderscheid welke bevindingen specifiek labrumletsel ondersteunen. Onderbouw de lage voorafkants (onder 10%) voor deze patiënt en corrigeer de genoemde taal- en grammaticafouten.

3. Klinische vraagstelling (stap 2) PASS

Je hebt de klinische vraag logisch opgebouwd: patiënt, indextest, referentietest, aandoening, NVW, voorafkants en beslisgrens zijn expliciet en toetsbaar verbonden. Echter, de voorafkants onder 10% is nog niet patiëntspecifiek onderbouwd. Harmoniseer vervolgens voorafkants, labrumletsel en referentietest en corrigeer de NVW/PVW-inconsistentie in bijlage 2.

4. Zoekstrategie (stap 3) FAIL

De reproduceerbaarheid van stap 3 en de onderbouwing van de artikelkeuze zijn incompleet; daardoor kan de lezer de zoekactie en casustoepasbaarheid niet controleren. Noteer datum, exacte PubMed-zoekstring met MeSH-termen en Booleaanse operatoren, faseaantallen en selectieargumenten. Vergelijk elk inclusie- en exclusie criterium met de casus.

5. Kritische evaluatie (stap 4) PASS

Je koppelt methodologische kenmerken terecht aan verificatie- en expectation bias en verbindt meerdere beperkingen aan Adib et al. (2023). Echter, maak in stap 4 per punt expliciet welk kenmerk welke bias en welk gevolg veroorzaakt. Bespreek in stap 5 referentiestandaard, beoordelaarsbetrouwbaarheid en work-up-, selectie- en spectrum bias.

6. Evidentietabel (stap 5) FAIL

Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Noteer per maat formule, invulling, uitkomst en afronding, koppel waarden aan Tabel 1, corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$. Orden artikel en 10%-voorafkants in hypothetische 2x2-tabellen van 1.000 personen.

7. Commentaar (stap 6) FAIL

Stap 6 werkt de klinische bruikbaarheid onvoldoende uit: de betekenis van een NVW van 0,98 en de lage specificiteit van 0,33 blijft onverbonden met patiënt en werkomgeving. Dit verhindert een onderbouwde toepasselijkheidsuitspraak. Bespreek wanneer een negatieve test MRA kan uitstellen en controleer berekeningen en bronnen.

8. Bottom line (stap 7) FAIL

Je Bottom Line maakt niet expliciet wat een negatieve Arlington-test betekent voor het diagnostische traject. Daardoor blijft de klinische handelingskeuze onduidelijk. Formuleer in één à twee zinnen of MRA direct geïndiceerd is en welke rol klinische follow-up speelt, rekening houdend met de beperkte generaliseerbaarheid.



Waar het uiteenloopt

Drie plekken waar jullie oordeel en dat van Eduface het verst uit elkaar liggen

Evidentietabel (stap 5)

MARLOES

Beide criteria voldaan. De tabel met sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden werd goedgekeurd.

EDUFACE

FAIL. "Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$."

Klopt die rekenfout? En als het klopt, hoe controleren jullie die tabel nu?

Algemeen

MARLOES

Alle vier de criteria voldaan: taalgebruik, woordenaantal, samenhang en titel.

EDUFACE

FAIL. "De CAT bevat taal- en terminologiefouten (...) Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst."

Zie jij die taalfouten? En herken je de passage die het model als ChatGPT-tekst aanwijst?

Klinisch scenario (stap 1), hier was jij juist strenger

MARLOES

Niet voldaan op één punt: het accent op de klinische relevantie en de motivatie voor de klinische vraag ontbrak.

EDUFACE

PASS. Het model tekent er wel bij aan dat de lage voorafkans onder 10% niet patiëntspecifiek is onderbouwd.

Jij liet hem hierop zakken, het model niet. Wat zag jij dat het model mist?

Tot slot

Twee vragen waar we het meest aan hebben.

Van de acht stukken feedback: hoeveel zou je ongewijzigd naar de student sturen?

Wat miste je, dat je zelf wél zou hebben opgemerkt?